Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:28
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:29
Temps mis	28 s
Points	0,20/4,00
Note	**1,00** sur 20,00 (**5**%)

Énoncé général

Un patient âgé de 23 ans consulte aux urgences pour altération de l'état général depuis une semaine. Il n'a pas d'antécédent médicaux particulier. Il présentait une fonction rénale et une NFS normale lors d'un bilan biologique datant d'il y a un an.

- TA 155/85 mmHg
- FC 95 bpm
- Sat 93% en air ambiant

Il est polypnéique et présente une pâleur cutanéo-muqueuse. L'examen cutané ne montre pas de lésions.

L'auscultation cardio-pulmonaire révèle des crépitants aux bases pulmonaires.

Vous faites réaliser un bilan biologique qui montre :

- Hb: 7 g/dl
- VGM: 70 fl
- Plaquettes: 370 G/L
- Créatininémie: 350 µmol/L
- Kaliémie: 4,5 mmol/L
- Réserve alcaline: 13 mmol/L

L'ionogramme urinaire montre :

- Natriurèse: 25 mmol/L
- Kaliurèse: 7 mmol/L
- Protéinurie: 4 grammes/L
- Rapport protéinurie/créatininurie: 300 mg/mmol
- Rapport albuminurie/créatininurie: 250 mg/mmol

L'ECBU montre :

- 250 hématies/mm^3
- Leucocytes: 5/mm^3
- Culture stérile

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les syndromes glomérulaires suivants, quel est celui qui correspond au patient ?

- a. Syndrome hémolytique et urémique
- b. Syndrome néphrotique pur
- c. Syndrome de glomérulonéphrite chronique
- d. Syndrome d'hématurie macroscopique récidivant ✖
- e. Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive

---

Question 2

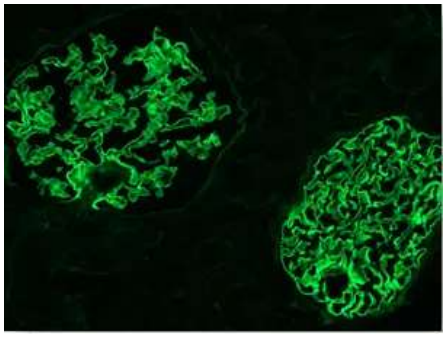
Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le patient est hospitalisé en néphrologie. Vous réalisez en urgence une biopsie rénale.

L'anatomopathologie retrouve en microscopie optique : glomérulonéphrite proliférative extra capillaire.

En immunofluorescence : dépôts linéaires d'anticorps IgG le long de la membrane basale glomérulaire (Cf. image associée).



Parmi les réponses suivantes, quel est le diagnostic exact (QRU) ?

- a. Vascularite à ANCA
- b. Glomérulonéphrite diabétique ✖
- c. Vascularite anti-MBG (anti-membrane basale glomérulaire) (ou maladie de Goodpasture)
- d. Vascularite à dépôts de complexe immuns
- e. Artérite à cellules géantes (anciennement maladie de Horton)

La réponse n'est pas correcte.

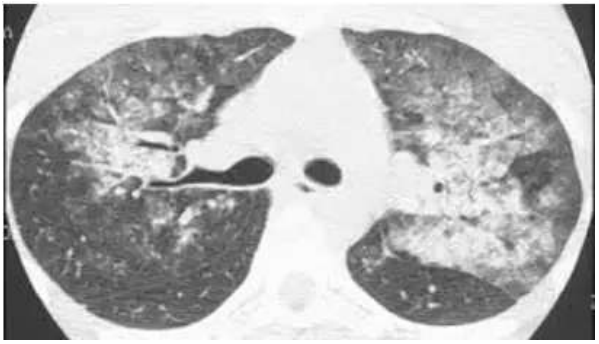
La réponse correcte est : Vascularite anti-MBG (anti-membrane basale glomérulaire) (ou maladie de Goodpasture)

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Dans la nuit, l'interne de garde est appelé car le patient présente des crachats sanglants. En regardant les constantes, vous constatez qu'il est subfébrile, qu'il nécessite désormais une oxygénothérapie à 3 litres/minutes et qu'il n'a presque pas uriné depuis environ 8 heures. L'auscultation retrouve désormais des crépitants bilatéraux sur l'ensemble des 2 champs pulmonaires. Vous faites réaliser un scanner qui montre l'image suivante.



Parmi les réponses suivantes, quels sont les diagnostics compatibles avec le tableau clinique et scannographique du patient (QRM) ?

- a. Hémorragie intra alvéolaire ✔
- b. Œdème aigue pulmonaire ✔
- c. Pneumothorax ✖
- d. Pneumonie bilatérale ✔
- e. Œdème de Quincke ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Hémorragie intra alvéolaire, Œdème aigue pulmonaire, Pneumonie bilatérale

---

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le diagnostic de vascularite à anticorps anti-MBG (ou maladie de Goodpasture) est évoqué.

Concernant le pronostic de la maladie de Goodpasture, quelles sont les réponses exactes (QRM) ?

- a. Dans 25% des cas, la poussée de la maladie évolue vers une rémission spontanée, c'est-à-dire sans traitement. ✖
- b. La récupération rénale se fait « ad integrum » après la poussée, c'est-à-dire sans séquelle. ✖
- c. Lors d'une poussée de la maladie, il existe un risque vital pour le patient. ✔
- d. La mise en dialyse permet dans la majorité des cas la rémission de la maladie. ✖
- e. Il existe un risque de rechute. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Lors d'une poussée de la maladie, il existe un risque vital pour le patient., Il existe un risque de rechute.